

INFLUENCIA DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE TOTAL SOBRE EL GRADO DE EXCLUSIÓN DE OFRECIMIENTOS.

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹

Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS:

Los centros de transfusión establecen objetivos anuales para responder a las necesidades hemoterápicas de su área sanitaria. En nuestra región (>1,5M habitantes) se programa mensualmente la distribución de las colectas y del personal requerido para realizarlas. Estos puntos de extracción (PE), presentan unas características que pueden explicar los índices de éxito-fracaso de las colectas.

OBJETIVO:

En este trabajo nos proponemos investigar si, en nuestra región, las características de las colectas tienen un impacto en el índice de exclusiones (IE).

MATERIAL Y MÉTODOS:

Estudio descriptivo retrospectivo de los PE de sangre total registrados en: el programa Hematos IIG, y en la planificación mensual de colectas de las unidades móviles (UM) desde 2008-2020. Las colectas se dividieron en: "Puntos Fijos" (PF) y UM. Estas últimas se clasificaron según su localización en:

- 1/ Centros de Salud / Municipios,
- 2/ Centros Educativos,
- 3/ Empresas/Hospitales/Organismos,
- 4/ Colectivos/Maratonos de donación.

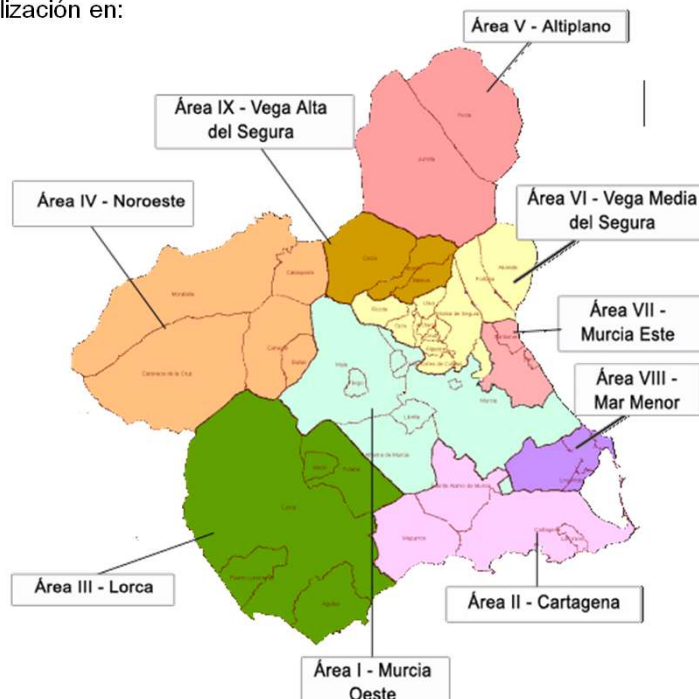
La frecuencia de visitas de las UM a los distintos PE se agruparon en:

- i) ≤ 1 /año,
- ii) 2-5/año,
- iii) 6-11/año,
- iv) ≥ 12 /año.

Según el número de exclusiones, el IE se clasificó en:

- A) $\leq 10\%$,
- B) 10-15%,
- C) 15,01-20%
- D) $> 20\%$.

Las colectas también se agruparon por estaciones del año para su estudio.



INFLUENCIA DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE TOTAL SOBRE EL GRADO DE EXCLUSIÓN DE OFRECIMIENTOS.

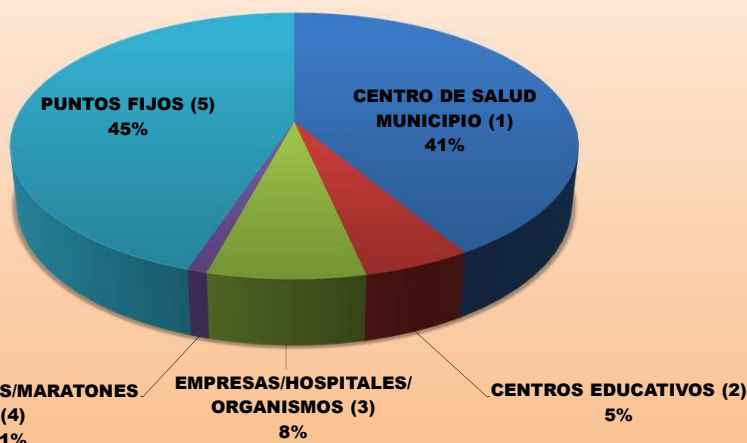
Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹

Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

RESULTADOS (I)

Se incluyeron 17114 colectas. La distribución fue: UM=52%, PF=45% (Gráfico 1). Según su localización; los PE "Habituales" suponen un 75% de colectas en UM y el 41% del total de colectas realizadas. Hasta Junio '2012 se cerraron dos PF y en consecuencia aumentaron las colectas en UM hasta el 60% (Tabla 1), donde se concentró el mayor número de donaciones, pasando, del 85% (2008-2010), al 88% (2011-2014) (Gráfico 2). Estos cambios hicieron que, desde 2013, se equiparasen los IE entre UM y PF, sobrepasando la barrera del 15% (Gráfico 3).

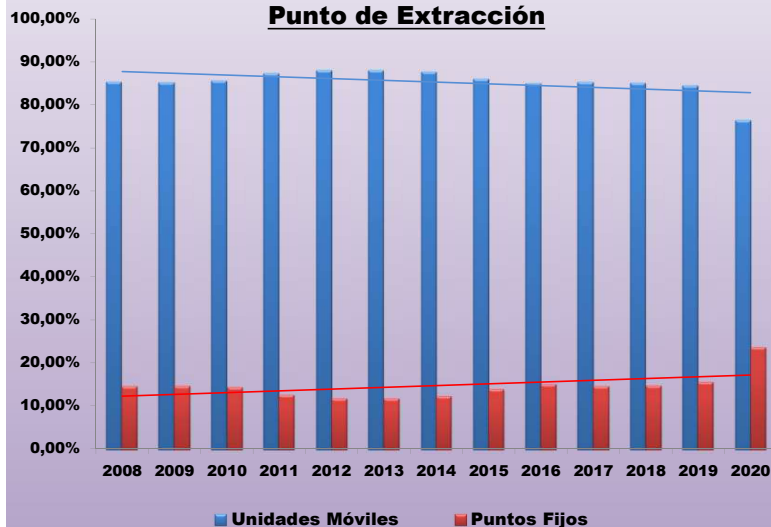
(Gráfico 1) **Distribución de los Puntos de Extracción**



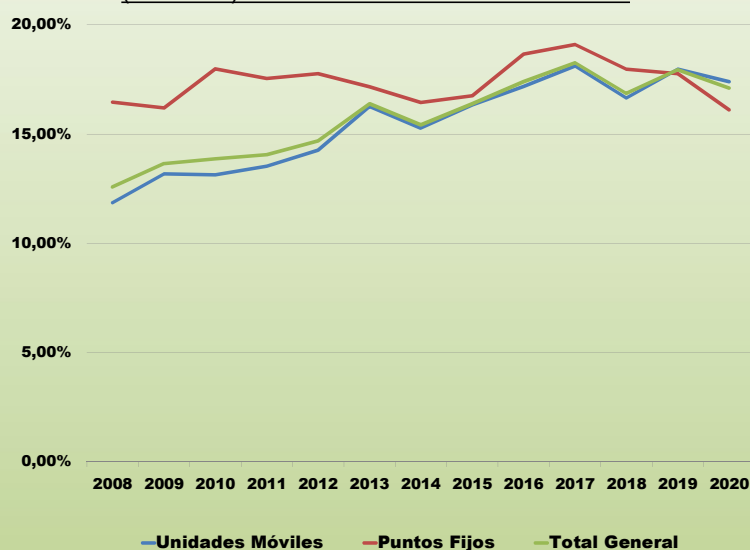
(Tabla 1) **Distribución de las colectas**

Periodo	Unidades móviles		Puntos fijos	
	n	%	n	%
2008-2020	9.714	56,75%	7401	43,25%
2008-2012	3.777	51,77%	3519	48,23%
2013-2020	5.936	60,46%	3882	39,54%

(Gráfico 2) **Donaciones obtenidas según el Punto de Extracción**



(Gráfico 3) **Índice Anual de Exclusiones**



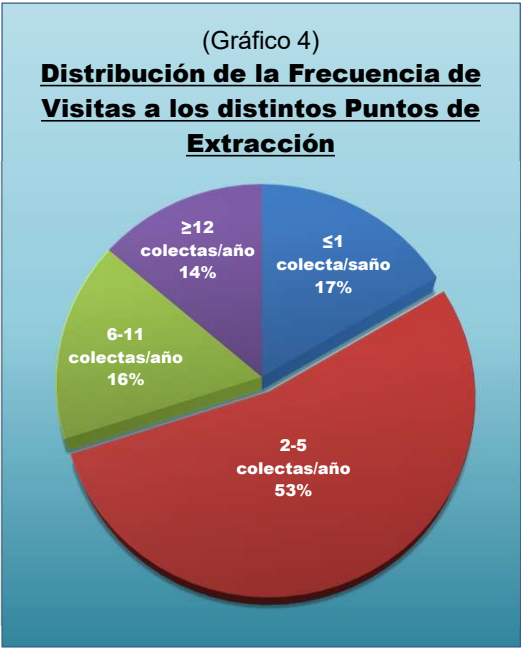
INFLUENCIA DE LOS PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE TOTAL SOBRE EL GRADO DE EXCLUSIÓN DE OFRECIMIENTOS.

Autores: Jorge Pagán Ortiz¹, Josué Pagán², Federico Serrano Valverde¹, Antonia Gómez Simón¹, María Luisa Lozano Almela¹, Vicente Vicente García¹, Francisca Ferrer Marín¹
Centros: ¹Centro Regional de Hemodonación, Murcia, ²Universidad Politécnica de Madrid, Madrid

RESULTADOS (II)

Por su frecuencia de visitas, el **53% de PE se visitaron 2-5 veces/año** (Gráfico 4). El 12.4% de las colectas que se visitan con una frecuencia 6-11 veces/año tiene un IE >20%. El IE >20%, en “Centros de Enseñanza” se presentó en >53% de estas colectas, seguido por colectas para “Colectivos-Maratones” que ocurrió en ~40% de las mismas. Además el IE global, también fue mayor en “Centros de Enseñanza” (22%), y el menor IE lo presentaron las colectas “Habituales” (14.6%). En el resto de tipos de colectas el IE fue ~17% (Tabla 3).

La media de donantes sangrados por colecta en invierno-primavera fue de 40,4 y menor en verano-otoño (<38,8 donaciones/colecta) (Tabla 2). Las diferencias encontradas en los IE según las estaciones del año fueron significativas (p=0,021) (Tabla 3).



(Tabla 2) **DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE COLECTA y GRADO IE**

TIPO DE COLECTA	I (≤10%)	II (10-15%)	III (15,01-20%)	IV (>20%)	IE Global
CENTRO DE SALUD/ MUNICIPIO (1)	21,96%	32,09%	26,64%	19,31%	14,59%
CENTRO DE ENSEÑANZA (2)	12,47%	12,47%	21,80%	53,26%	22,13%
EMPRESAS/HOSPITALES/ ORGANISMOS (3)	20,54%	22,47%	22,78%	34,21%	17,20%
COLECTIVOS/ MARATONES (4)	10,98%	23,17%	26,22%	39,63%	17,47%

(Tabla 3) **Influencia de las Estaciones del año**

Estación	IE (Excluidos/Previstos)	Rendimiento (Donaciones/Nº Colectas)
Invierno	15,79%	40,6
Primavera	15,75%	40,2
Verano	15,10%	39,22
Otoño	16,18%	38,32

CONCLUSIÓN:

- Nuestro IE de la donación supera el 15%, aunque en los últimos años (2020-2022) está disminuyendo.
- En los PE donde se atiende a “donantes no habituales” (“Centros educativos” y “Empresas y maratones de donación”) el IE es mayor.
- Las colectas que menos se visitan presentan un IE más alto.
- El IE disminuye conforme aumenta la frecuencia de visitas a los PE, explicable por el efecto cribado de las primeras visitas y la fidelización del resto de donantes.
- Existe influencia según las estaciones del año en el IE.